

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC**



BÁO CÁO CÁ NHÂN

Sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến trong dự án nhóm

Họ và tên:	Nguyễn Tùng Dương
Mã sinh viên:	22100220
Lớp:	VNU1001_E252023
Môn học:	Nhập môn CNS&AI
Chủ đề dự án:	Phân tích case lâm sàng tăng huyết áp – đánh giá và đề xuất điều trị

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

I. MỤC TIÊU VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN.....	3
1. Mục tiêu cốt lõi (theo yêu cầu đạt mức 4 rubic)	3
2. Bối cảnh thực hiện.....	3
II. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC SỐ.....	4
1. Kỹ năng thiết lập & sử dụng công cụ.....	4
2. Quản lý tác vụ & tương tác cá nhân.....	8
3. Quản lý tài nguyên & tệp tin	12
I. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG CỤ.....	14
1. Google Meet: Không gian giao tiếp và điều phối đồng bộ	14
2. Google Docs: Xử lý văn bản và cộng tác nhóm.....	15
3. Trello: Quản trị tiến độ và tối ưu hóa sự tập trung.....	15
4. Google Drive: Kho lưu trữ tiện lợi.....	16
II. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC TIỄN	16
1. Thách thức 1: Rào cản đồng bộ hóa tiến độ (Trello)	16
2. Thách thức 2: Rủi ro rời rạc nội dung và xung đột định dạng (Google Docs)	17
3. Thách thức 3: Phân mảnh tài nguyên và rủi ro quyền truy cập (Google Drive)	18
4. Thách thức 4: Quá tải thông báo và khó theo dõi luồng thảo luận chuyên môn trên Microsoft Teams	18
III. TỔNG KẾT	19

I. MỤC TIÊU VÀ BỐI CẢNH DỰ ÁN

1. Mục tiêu cốt lõi (theo yêu cầu đạt mức 4 rubic)

- **Mục tiêu 1 – Thiết lập & vận hành đa công cụ:** Sử dụng thành thạo ít nhất 3 công cụ trực tuyến thuộc các nhóm khác nhau (quản lý dự án, soạn thảo, lưu trữ, giao tiếp), có tích hợp tag/label hoặc tự động hóa để tối ưu không gian làm việc số.
- **Mục tiêu 2 – Quản lý tác vụ và tương tác cá nhân:** Đảm bảo 100% nhiệm vụ cá nhân được mô tả, phân công, có deadline rõ ràng; cập nhật tiến độ ít nhất 3 lần/tuần; chủ động tương tác, hỗ trợ thành viên khác với trên 10 lượt thảo luận/tuần.
- **Mục tiêu 3 – Tổ chức tài nguyên số:** Xây dựng hệ thống thư mục nhiều cấp logic, đặt tên file theo quy chuẩn thống nhất (100%), thiết lập phân quyền truy cập (view/edit) phù hợp cho từng tệp.
- **Mục tiêu 4 – Báo cáo & minh chứng:** Hoàn thiện báo cáo cá nhân dài 4-5 trang, phân tích sâu 3 thách thức và 3 giải pháp thực tế khi làm việc nhóm, kèm trên 8 ảnh chụp màn hình sắc nét, rõ tên tài khoản cá nhân và tiến trình làm việc theo tuần.

2. Bối cảnh thực hiện

- **Dự án nhóm được giao:** “Phân tích case lâm sàng tăng huyết áp – đánh giá và đề xuất điều trị” dựa trên hồ sơ bệnh án thật của bệnh nhân nam 81 tuổi, nhập viện vì đau ngực trái, có tiền sử tăng huyết áp 10 năm, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu nặng (LDL-C 5,4 mmol/L), hẹp động mạch cảnh và có cơn đau thắt ngực.
- **Vai trò cá nhân trong nhóm:**

Thành viên	Vai trò
Vũ Thị Duyên	Tóm tắt bệnh án
Nguyễn Việt Dũng	Phụ trách phân tích kết quả xét nghiệm sinh hóa (glucose, cholesterol, LDL, HDL, triglycerid, creatinin, acid uric).
Nguyễn Ngọc Diệp	Đánh giá phân tầng nguy cơ tim mạch (theo ESC) và xác định mức nguy cơ rất cao
Nguyễn Tùng Dương	- Nhận xét tính phù hợp, hiệu quả và an toàn của các đơn thuốc ngày 06/11, 07/11, 08/11

	- Đề xuất điều chỉnh phác đồ (tăng liều statin, thay ACEi bằng ARB, bổ sung thuốc điều trị đau thắt ngực)
Lưu Hải Đăng	Tham gia phản biện và duyệt chéo các phần tiền sử, siêu âm, kế hoạch điều trị do thành viên khác thực hiện

- Hệ thống công cụ sử dụng (đáp ứng mức 4):

- **Quản lý dự án:** Trello (có label phân loại, checklist, due date, automation với Slack).
- **Soạn thảo cộng tác:** Google Docs (chế độ suggesting, version history, comment).
- **Lưu trữ & chia sẻ:** Google Drive (thư mục 3 cấp, quy tắc đặt tên: Tên file = [STT]_[Tên nội dung]).
- **Giao tiếp nhóm:** Microsoft Teams (họp định kỳ, chat kênh, chia sẻ màn hình, lưu lịch sử thảo luận)
- **Thời gian thực hiện:** 1 tuần (từ ngày 12/04/2026 đến 18/04/2026), với các mốc cập nhật tiến độ cụ thể vào các ngày 13/04, 15/04, 17/04, 18/04.

II. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC SỐ

1. Kỹ năng thiết lập & sử dụng công cụ

- Để quản lý dự án phân tích case lâm sàng yêu cầu độ chính xác cao và phối hợp nhịp nhàng, nhóm em đã chủ động lựa chọn và vận hành đồng bộ 5 nền tảng thuộc 4 nhóm khác nhau, bao gồm: Quản lý dự án (Trello), Lưu trữ (Google Drive), Soạn thảo cộng tác (Google Docs) và Giao tiếp (Microsoft Teams).

Nhóm công cụ	Công cụ	Cách tối ưu hóa đạt mức 4
Quản lý dự án	Trello	Sử dụng label (Họp, Nhiệm vụ, Đang làm, Chờ duyệt, Đã xong) và tag phân loại (Tiền sử, Xét nghiệm, Điều trị). Tích hợp Power-Up Butler để tự động gửi thông báo sang Teams khi thẻ được chuyển cột hoặc đến hạn.

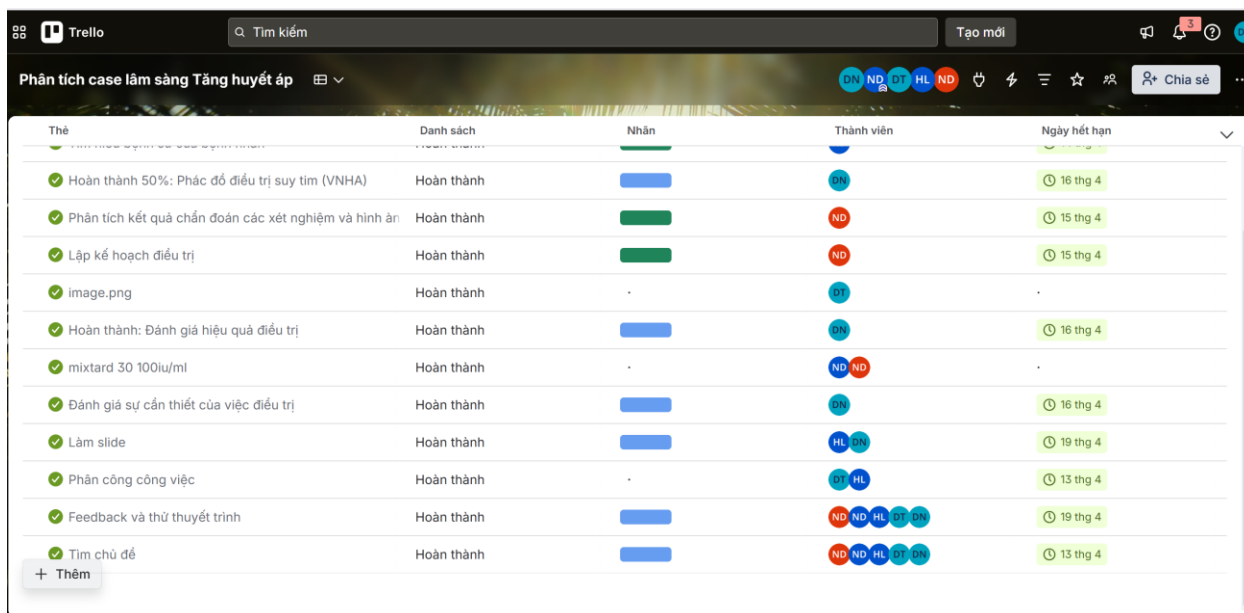
Soạn thảo cộng tác	Google Docs	Dùng chế độ Suggesting để tránh xung đột, bật Version History để theo dõi đóng góp từng thành viên, sử dụng Comment để phản biện trực tiếp.
Lưu trữ & chia sẻ	Google Drive	Xây dựng cây thư mục 3 cấp có cấu trúc, đặt tên file theo quy chuẩn thống nhất, phân quyền Editor/Viewer cụ thể cho từng thư mục.
Giao tiếp nhóm	Microsoft Teams	Tạo kênh riêng, dùng thread cho từng chủ đề, lưu trữ toàn bộ lịch sử chat và file đính kèm, kết hợp họp định kỳ có ghi hình.

- Các thành viên phụ trách chính trong bảng phân công công việc là những người tạo mẫu và các thành viên còn lại trực tiếp soạn thảo các mục. Mọi đóng góp đều được hệ thống ghi nhận rõ tên tài khoản trong Lịch sử phiên bản.

- Các tài khoản được hiết lập đầy đủ, có kết nối cơ bản giữa ít nhất 2 công cụ

- **Mình chứng:**

- Trello:



- Teams: Ảnh kênh chat với các thread thảo luận chuyên môn

- Cộng tác trên công cụ soạn thảo tài liệu: Google Docs

2. Quản lý tác vụ & tương tác cá nhân

- **Phân công và cam kết:** 100% nhiệm vụ cá nhân trên Trello đều có mô tả chi tiết, gán đúng tên thành viên phụ trách và thiết lập **Due date** rõ ràng. Ví dụ: thẻ “Đánh giá hiệu quả điều trị” do em đảm nhận, deadline 16/04.

- **Cập nhật tiến độ (≥3 lần/tuần):**

- Lần 1 (13/04): Comment “Đã thu thập số liệu xét nghiệm, đang tổng hợp”.
- Lần 2 (15/04): Chuyển thẻ từ “Cần làm” sang “Đang làm”, kèm checklist hoàn thành 50%.
- Lần 3 (17/04): Chuyển thẻ sang “Đã xong”, đính kèm link Google Docs đã hoàn thiện.

Mỗi lần cập nhật đều được chụp ảnh activity log trên Trello có tên em và timestamp.

- **Tương tác chủ động (>10 lượt/tuần):**

+ Trên kênh Teams: Tăng huyết áp – đánh giá và đề xuất điều trị

The screenshot displays a Microsoft Teams interface during a meeting. On the left, a presentation slide titled "Hình 4. Quy trình điều trị suy tim phân suất tống máu giảm" is visible. The slide contains a flowchart with three main branches: "ACETABOLIN", "DIGOXIN", and "FOSPHATIDIC ACID". The central branch "DIGOXIN" is highlighted in green. The right branch "FOSPHATIDIC ACID" is highlighted in yellow. The bottom branch "ACETABOLIN" is highlighted in blue. The slide also includes text about the ACE-I group and the need for monitoring. In the center, a Google Docs document titled "Phân tích case lâm sàng Tăng H..." is open, showing a table with columns for "NGÀY", "DIỄN BIẾN BỆNH", and "Y LỆNH". The table contains data for a patient named "BN nam 51 tuổi vào viện vì đau ngực". On the right, a chat window titled "Trò chuyện trong cuộc họp" is open, showing a conversation between "Nguyễn Ngọc Diệp" and "Nguyễn Ngọc Diệp" about the patient's condition. The chat text includes: "mặc hồng hào cho thấy tình trạng tuần hoàn và oxy hóa máu tương đối đảm bảo. Các dấu hiệu sinh tồn nhân chứng trong giới hạn cho phép, tuy nhiên huyết áp 150/90 mmHg ghi nhận tình trạng tăng huyết áp, cần theo dõi và kiểm soát. Nhịp tim không đều với tần số 80 bpm/phút gợi ý rối loạn nhịp, cần đánh giá thêm bằng cân lâm sàng (điện tim) để xác định nguyên nhân, hỗ trợ điều trị, không có dấu hiệu suy hô hấp hay tổn thương phổi. Khám bụng và hệ tiêu hóa chưa phát hiện bất thường. Xét nghiệm huyết học trong giới hạn bình thường, chưa ghi nhận rối loạn và đông tế bào máu. Tổng thể bệnh nhân chưa có biểu hiện tổn thương cơ quan rõ ràng nhưng cần tiếp tục theo dõi tim mạch và huyết áp."

22100220-Nguyễn Tùng Dương

16:55

Ghi

Chat

Mọi người

Giới tay

Phản ứng

Dang xem

Khác

Camera

Micro

Dừng chia sẻ

Rời đi

Dương Nguyễn Tùng

vuduyen0512 (Khách)

22100223-Lưu Hải Đăng (Khách)

22100214-Nguyễn Việt Dũng (Khách)

Nguyễn Ngọc Diệp

22100217 - Vũ Thị Duyên (Khách)

2

teams.live.com is sharing your screen. Stop sharing Hide

Trò chuyện trong cuộc họp

thường phải khám định và hệ tiết niệu chưa phát hiện bất thường. Kết nghiệm huyết học trong giới hạn bình thường, chưa ghi nhận rối loạn về đông tế bào máu. Tổng thể, bệnh nhân chưa có biểu hiện tổn thương cơ quan rõ ràng nhưng cần tiếp tục theo dõi tim mạch và huyết áp.

Nguyễn Ngọc Diệp

ND. Dùng thuốc thì cần đạt mục tiêu huyết áp là bao nhiêu?

22100217 - Vũ Thị Duyên (Khách) đã được mời tham dự cuộc họp.

Tin nhắn đọc gần đây nhất

22100217 - Vũ Thị Duyên (Khách)

2. bệnh nhân nam, lớn tuổi, đang dùng insulin, thuốc hạ đường huyết uống, thuốc hạ áp và aspirin. Đánh giá hợp lý kh

Nguyễn Ngọc Diệp: 18/04/2026 8:13 CH
Dùng thuốc thì cần đạt mục tiêu huyết áp là bao nhiêu?
HATT < 90 mmHg, HATr < 130 mmHg

22100214 - Nguyễn Việt Dũng (Khách)

Nhập tin nhắn

22100220-Nguyễn Tùng Dương

17:27

Ghi

Chat

Mọi người

Giới tay

Phản ứng

Dang xem

Khác

Camera

Micro

Chia sẻ

Rời đi

Dương Nguyễn Tùng

vuduyen0512 (Khách)

22100223-Lưu Hải Đăng (Khách)

22100214-Nguyễn Việt Dũng (Khách)

Nguyễn Ngọc Diệp

22100217 - Vũ Thị Duyên (Khách)

2

Trò chuyện trong cuộc họp

22100214-Nguyễn Việt Dũng (Khách)

2D. Liệu dùng và thời điểm uống Diamicon MR đã tối ưu để đạt hiệu quả điều trị và hạn chế tác dụng phụ chưa?

22100217 - Vũ Thị Duyên (Khách) 18/04/2026 8:16 CH
bệnh nhân nam, lớn tuổi, đang dùng insulin, thuốc hạ đường huyết uống, thuốc hạ áp và aspirin. Đánh giá hợp lý kh
Hợp lý, dùng thêm aspirin để phòng ngừa biến cố tim mạch

22100223-Lưu Hải Đăng (Khách)

2D. 22100214-Nguyễn Việt Dũng (Khách) 18/04/2026 8:17 CH
Liệu dùng và thời điểm uống Diamicon MR đã tối ưu để đạt hiệu quả điều trị và hạn chế tác dụng phụ chưa?

Diamicon MR tối ưu khi uống **1 lần/ngày vào bữa sáng**. Nếu kiểm soát đường huyết tốt và không hạ đường huyết → liều dùng đã phù hợp, nếu chưa đạt mục tiêu hoặc có tác dụng phụ → cần điều chỉnh liều.

Nguyễn Ngọc Diệp

Nhập tin nhắn

- Minh chứng:

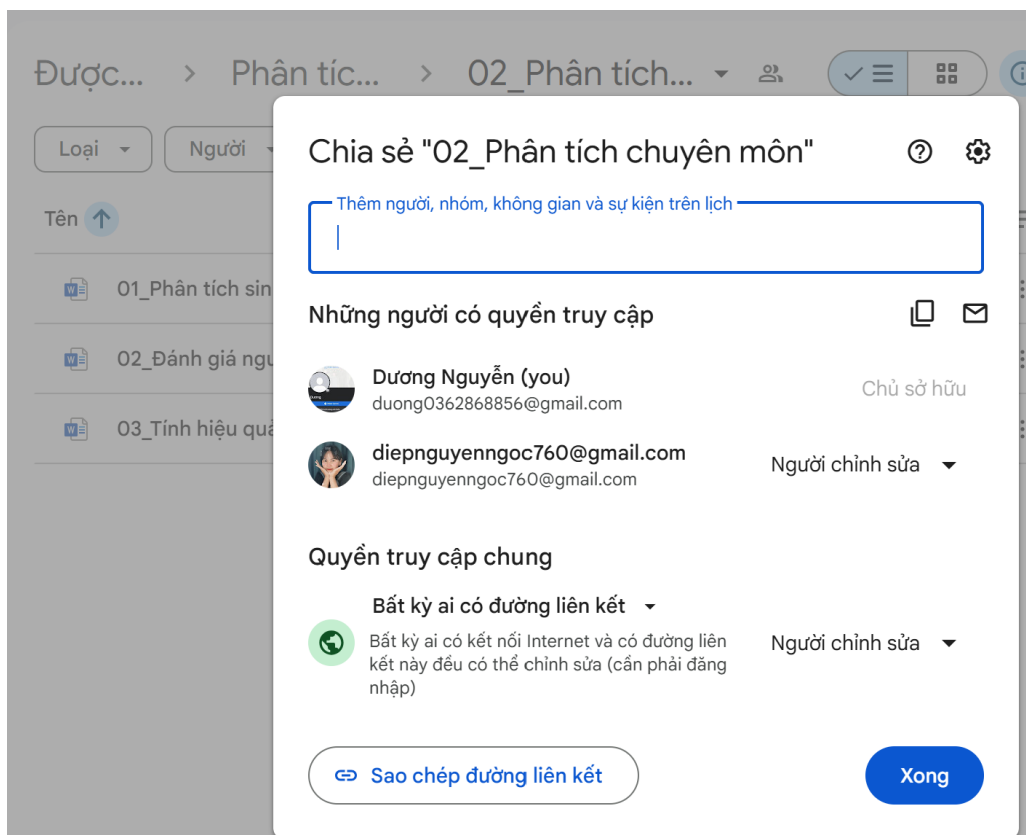
The screenshot shows the Google Drive web interface. On the left is the navigation sidebar with options like 'Mới', 'Trang chủ', 'Drive của tôi', 'Máy tính', and 'Được chia sẻ với tôi'. The main area displays a folder titled 'Được chia sẻ ... > Phân tích case lâm sàng ...'. Below the folder name are filters for 'Loại', 'Người', 'Lần sửa đổi gần đây nhất', and 'Nguồn'. A table lists files within the folder:

Tên	Ngày sửa đổi
01_Tài liệu bệnh án	23:22
02_Phân tích chuyên môn	23:22
03_Tài liệu tham khảo	23:21
04_Báo cáo nhóm	23:21
05_Minh chứng ảnh	23:22

On the right, a sidebar for the selected folder 'Phân tích case lâm sàng tăng huyết áp' shows 'Chi tiết' and 'Hoạt động' tabs. It includes a section for 'Người có quyền truy cập' (Users with access) and a 'Giới hạn về mức bảo mật' (Limit security level) section.

This is a close-up view of the file list from the previous screenshot. The breadcrumb path is 'Được ... > Phân tích... > 02_Phân tích ...'. A toolbar at the top shows icons for selection, sharing, download, move, delete, and link. The table below lists three Word documents:

Tên	Ngày sửa đổi
01_Phân tích sinh hóa - Dũng.docx	23:45
02_Đánh giá nguy cơ tim mạch - Diệp.docx	23:45
03_Tính hiệu quả điều trị thuốc - Dương.docx	23:46



III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG CỤ

1. Google Meet: Không gian giao tiếp và điều phối đồng bộ

- Tập trung hóa kênh làm việc: Teams cho phép tạo kênh riêng, nơi mọi thảo luận chuyên môn (phân tích chỉ số xét nghiệm, bàn luận về đơn thuốc, đề xuất phác đồ) được lưu lại đầy đủ. Nhờ đó, không còn tình trạng thông tin bị “trôi” như khi dùng các ứng dụng nhắn tin thông thường.
- Tổ chức thảo luận theo chủ đề: Tính năng luồng hội thoại (thread) giúp tách bạch từng vấn đề y khoa (ví dụ: một thread riêng cho “LDL-C mục tiêu theo ESC 2024”, một thread khác cho “Đánh giá tương tác thuốc giữa Perindopril và Aspirin”). Nhờ vậy, các thành viên dễ dàng theo dõi và phản hồi đúng nội dung, không bị nhiễu bởi các chủ đề khác.
- Tích hợp lịch họp và ghi hình: Lên lịch họp trực tiếp trên Teams, tự động đồng bộ với Outlook Calendar. Tính năng Record (ghi hình) buổi họp (được sự đồng ý của nhóm) giúp các thành viên vắng mặt hoặc cần xem lại có thể nắm bắt đầy đủ các quyết định quan trọng như phân tích kết quả siêu âm động mạch cảnh hay thống nhất điều chỉnh liều statin.

- Chia sẻ màn hình và cùng duyệt tài liệu: Khi họp, trưởng nhóm hoặc em sử dụng Share screen để chiếu trực tiếp bảng Trello, file Google Docs tổng hợp phân tích. Cả nhóm vừa nhìn vừa góp ý, chốt nhanh các phần như bảng đánh giá đơn thuốc hay kế hoạch điều trị (P-plan), giảm tối đa thời gian chờ đợi.

2. Google Docs: Xử lý văn bản và cộng tác nhóm

- Làm việc đồng thời, không lo xung đột: Nội dung báo cáo case lâm sàng được chia thành các phần (tiền sử, xét nghiệm, đánh giá nguy cơ, nhận xét đơn thuốc, kế hoạch điều trị). Mỗi thành viên phụ trách một phần, có thể cùng lúc chỉnh sửa trên cùng một tài liệu. Chế độ Suggesting (gợi ý) cho phép đề xuất thay đổi mà không làm hỏng nội dung gốc, rất hữu ích khi phản biện các chỉ số sinh hóa hay kết luận về rối loạn lipid máu.
- Lịch sử phiên bản minh bạch: Vào File > Version history, ai cũng thấy được ai đã viết, sửa, thêm phần nào. Em đã dùng tính năng này để chứng minh các đóng góp cá nhân như bảng phân tầng nguy cơ tim mạch hay nhận xét về tương tác thuốc. Không còn tình trạng “đổ vấy” hay tranh cãi về trách nhiệm.
- Comment thảo luận trực tiếp trên văn bản: Khi đọc phần của bạn khác, em có thể bôi đen một câu (ví dụ “Creatinin 112 mmol/L → bệnh thận mạn G3a”) và để lại comment góp ý hoặc yêu cầu giải thích thêm. Các câu hỏi và câu trả lời được lưu lại, tạo thành một lớp “phản biện y khoa” song song với văn bản chính.
- Lưu trữ tự động: Xóa bỏ hoàn toàn rủi ro mất dữ liệu do sự cố máy tính hoặc cúp điện đột ngột

3. Trello: Quản trị tiến độ và tối ưu hóa sự tập trung

- Trực quan hóa luồng công việc (Kanban): Bảng Trello được chia thành các cột: Cần làm, Đang làm, Chờ duyệt, Đã xong. Mỗi thẻ là một đầu việc cụ thể (ví dụ: “Phân tích xét nghiệm sinh hóa”, “Đánh giá đơn thuốc ngày 07/11”). Nhờ đó, chỉ cần nhìn lướt là biết dự án đang tắc ở khâu nào, ai đang làm gì
- Hệ thống label và tag tinh gọn: Nhóm đặt các label theo bản chất công việc: Nhiệm vụ, Họp, Đang tiến hành, Chờ duyệt, Đã duyệt. Kết hợp với tag (Tiền sử, Xét nghiệm, Điều trị) giúp lọc thẻ cực nhanh khi cần tổng hợp tất cả các việc liên quan đến “Xét nghiệm” hay “Điều trị”. Đây là yêu cầu ở mức 4 của rubric
- Chi tiết hóa tác vụ bằng checklist và due date: Trong thẻ “Phân tích xét nghiệm sinh hóa”, em tạo checklist: Thu thập số liệu, Tính toán mức lọc cầu thận (eGFR), So sánh với ngưỡng khuyến cáo, Viết nhận xét. Mỗi mục nhỏ được đánh dấu hoàn thành, giúp không bỏ sót bất kỳ chỉ số nào. Deadline được đặt cụ thể đến từng ngày, tạo áp lực tích cực để hoàn thành đúng tiến độ

- Tích hợp với Teams qua Power-Up Butler: Thiết lập tự động: khi một thẻ được chuyển sang cột “Chờ duyệt” hoặc khi đến hạn mà chưa được cập nhật, Trello sẽ gửi tin nhắn thông báo vào kênh Teams tương ứng. Điều này giảm tải việc phải nhắc nhở thủ công và đảm bảo không ai bỏ lỡ thông tin quan trọng

4. Google Drive: Kho lưu trữ tiện lợi

- Cấu trúc thư mục khoa học, nhiều cấp: Drive được tổ chức thành cây thư mục rõ ràng: thư mục gốc [PHÂN TÍCH CASE LS THA], bên trong chia nhỏ 01_Tài liệu bệnh án (Tiền sử BN, kết quả XN, phân tích hiệu quả điều trị của thuốc); 02_Phân tích chuyên môn (Phân công nhiệm vụ: Phân tích sinh hóa-Dũng, Đánh giá nguy cơ tim mạch-Diệp, Phân tích hiệu quả điều trị-Dương).; 03_Tài liệu tham khảo (AHA, ACC, ESC, VNHA); 04_Báo cáo nhóm (Chủ đề chương trình, Kịch bản MC, Bộ câu hỏi, Tình huống thảo luận); 05_Mình chứng ảnh. Mỗi thư mục lại có thể có thư mục con (ví dụ: Phân tích sinh hóa, đánh giá nguy cơ). Cách này rút ngắn 80% thời gian tìm kiếm so với lưu trữ lộn xộn
- Quy tắc đặt tên file thống nhất: Nhóm thống nhất cú pháp [STT]_[Tên nội dung]. Ví dụ: 01_Tài liệu bệnh án. 100% file tuân thủ quy tắc này, giúp dễ dàng sắp xếp, tìm kiếm và tránh ghi đè nhầm lẫn
- Phân quyền truy cập linh hoạt: Em thiết lập quyền Editor cho các thành viên trực tiếp làm việc trên file phân tích của mình, nhưng chuyển sang Viewer hoặc Commenter đối với các file kế hoạch đã được chốt. Đối với thư mục chứa mình chứng ảnh, tất cả thành viên đều có quyền xem, chỉ riêng em (người thu thập) có quyền chỉnh sửa. Nhờ vậy, dữ liệu được bảo vệ an toàn, không sợ sửa sai ngoài ý muốn.
- Tích hợp với Google Docs và Teams: Drive làm nền tảng lưu trữ chính; mọi link Google Docs đều được nhúng trong Trello và chia sẻ trên Teams. Khi cần gửi báo cáo tạm thời cho giảng viên, em chỉ cần sao chép link đã được cấp quyền phù hợp, tránh tình trạng “yêu cầu truy cập” gây gián đoạn
- Bảo vệ tài nguyên an toàn: Xóa bỏ rủi ro hỏng hóc thiết bị vật lý (USB) sát ngày diễn ra sự kiện.

IV. PHÂN TÍCH THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC TIỄN

1. Thách thức 1: Rào cản đồng bộ hóa tiến độ (Trello)

- Vấn đề:

Case bệnh án có rất nhiều số liệu xét nghiệm (glucose 7,9 mmol/L, LDL-C 5,4 mmol/L,

creatinin 112 $\mu\text{mol/L}$...) và các đánh giá phân tầng nguy cơ. Ban đầu, em viết nhận xét trên Google Docs, nhưng trên Trello thì chỉ đề tiêu đề thẻ “Phân tích xét nghiệm”. Khi trưởng nhóm muốn kiểm tra nhanh tiến độ, phải mở cả hai nền tảng, dẫn đến mất thời gian và có khi bỏ sót thông tin (ví dụ quên cập nhật chỉ số eGFR đã tính được). Sự bất đồng bộ này khiến một thành viên khác tưởng em chưa làm phần creatinin, dẫn đến làm trùng việc.

- Giải pháp:

Nhóm em quy định: **Mỗi thẻ Trello bắt buộc phải có phần mô tả (Description) tóm tắt kết quả chính và kèm link trực tiếp đến file Google Docs tương ứng.** Cụ thể, trong thẻ “Phân tích xét nghiệm sinh hóa”, em dán link lên Trello. Đồng thời, trên Google Docs, em thêm một dòng tiêu đề “Bản cập nhật ngày:” và cập nhật thủ công ngày hoàn thành từng phần. Khi kết thúc mỗi ngày, em chụp màn hình phần mô tả thẻ Trello có chứa link và timestamp, gửi vào kênh Teams như một “bản cam kết tiến độ”.

- Kết quả:

Từ ngày thứ 3 trở đi, không còn tình trạng làm trùng hay bỏ sót dữ liệu. Trưởng nhóm chỉ cần xem Trello là biết ngay em đã hoàn thành những chỉ số nào, link đến file chi tiết ở đâu. Thời gian kiểm tra tiến độ giảm 70%.

2. Thách thức 2: Rủi ro rời rạc nội dung và xung đột định dạng (Google Docs)

- Vấn đề:

Báo cáo case lâm sàng được chia thành 5 phần lớn: (1) Tiền sử, (2) Xét nghiệm và hình ảnh, (3) Đánh giá điều trị (A), (4) Kế hoạch (P), (5) Bàn luận. Có 4 thành viên cùng lúc viết các phần khác nhau trên cùng một file. Mặc dù Google Docs cho phép làm việc đồng thời, nhưng có lúc em đang viết phần nhận xét về rối loạn lipid máu thì bạn khác vô tình xóa mất một đoạn công thức tính eGFR do chọn nhầm chế độ “Editing” thay vì “Suggesting”. Ngoài ra, định dạng bảng (bảng so sánh chỉ số LDL-C với khuyến cáo ESC) bị lệch cột khi hai người cùng chỉnh sửa.

- Giải pháp:

Nhóm em thống nhất “**Quy trình 2 bước**” cho mọi thay đổi quan trọng:

- **Bước 1 – Đề xuất:** Tất cả thành viên, trừ người được phân công chính của phần đó, bắt buộc chuyển sang chế độ **Suggesting** (gợi ý). Các gợi ý sẽ hiện màu xanh, người chủ phần có thể duyệt hoặc từ chối.
- **Bước 2 – Họp chốt trên Teams:** Mỗi tối, nhóm họp 15 phút, chia sẻ màn hình file Google Docs, lần lượt duyệt từng gợi ý và thống nhất phương án. Các bảng

biểu phức tạp (ví dụ bảng đánh giá đơn thuốc ngày 07/11) được giao cho một người duy nhất định dạng, những người khác chỉ comment chứ không trực tiếp sửa.

Ngoài ra, em đã tạo một bản sao lưu (File > Make a copy) trước mỗi buổi họp lớn, đề phòng trường hợp cần khôi phục.

- Kết quả:

Không còn xung đột chỉnh sửa hay mất dữ liệu. Định dạng bảng được giữ nguyên xuyên suốt. Tốc độ hoàn thiện báo cáo tăng 50% so với tuần đầu.

3. Thách thức 3: Phân mảnh tài nguyên và rủi ro quyền truy cập (Google Drive)

Vấn đề: Trong những ngày đầu, các thành viên tải tài liệu lên Drive một cách tự do, không đưa vào thư mục cụ thể và đặt tên file thiếu đồng bộ. Hơn nữa, khi gửi link Kế hoạch cho Cấp trên duyệt, thường xuyên xảy ra lỗi “Cần cấp quyền truy cập”, làm gián đoạn luồng làm việc.

Giải pháp: Thiết lập “Cây thư mục chuẩn”. Ban hành quy ước đặt tên file thống nhất. Leader là người duy nhất chịu trách nhiệm mở quyền chia sẻ dạng Viewer/Editor trước khi gửi link cho các bên ngoại bộ.

Kết quả: Rút ngắn 80% thời gian tìm kiếm tài nguyên. Dữ liệu được tập trung, cấu trúc rõ ràng và duy trì được sự chuyên nghiệp tuyệt đối khi làm việc liên phòng ban.

4. Thách thức 4: Quá tải thông báo và khó theo dõi luồng thảo luận chuyên môn trên Microsoft Teams

- Vấn đề:

Teams là nơi nhóm trao đổi liên tục về các vấn đề chuyên môn của case: từ việc thống nhất phân tầng nguy cơ tim mạch, bàn luận về tương tác thuốc giữa Perindopril và Aspirin, đến gửi link tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, do kênh #CaseTHA_NhomX có quá nhiều tin nhắn mỗi ngày (cả thảo luận chính và các câu hỏi nhỏ, thậm chí cả tin nhắn xã giao), các thông báo quan trọng như “đã upload file phân tích LDL-C mới” hoặc “thay đổi lịch họp” thường xuyên bị trôi lên trên. Có lần em đã bỏ lỡ thông báo về việc chỉnh sửa công thức tính eGFR, dẫn đến phải làm lại một phần báo cáo. Bên cạnh đó, việc trả lời các câu hỏi cũ bị đứt quãng vì mỗi lần mở lại phải cuộn tìm từ hàng trăm tin nhắn.

- Giải pháp:

Nhóm em đã áp dụng bộ quy tắc “**Teams thông minh**” gồm 3 biện pháp:

- **Sử dụng luồng hội thoại (thread) bắt buộc cho mọi chủ đề chuyên môn.**
Ví dụ: Khi muốn thảo luận về “Mục tiêu LDL-C theo ESC 2024”, một thành viên tạo thread riêng. Tất cả các phản hồi liên quan đều nằm trong thread đó, không làm loãng kênh chính. Nhờ vậy, sau 3 ngày em vẫn dễ dàng tìm lại toàn bộ ý kiến để tổng hợp vào báo cáo.
- **Ghim (pin) tối đa 3 tin nhắn quan trọng nhất tại mỗi thời điểm.**
Nhóm ghim: (1) Link đến bảng Trello tổng hợp, (2) Link đến file Google Docs báo cáo chính, (3) Thông báo lịch họp tuần. Các thành viên được nhắc nhở kiểm tra tin nhắn đã ghim trước khi hỏi lại thông tin cơ bản.
- **Đặt kênh riêng cho các thông báo khẩn cấp và lịch họp.**
Em tạo thêm kênh #Thong_bao_quan_trong chỉ dành cho trưởng nhóm và phó nhóm đăng tin. Mọi thông báo về deadline, thay đổi phân công, hoặc yêu cầu họp đột xuất đều được đăng ở đây và **mentions @channel** để tất cả thành viên nhận thông báo đẩy (push notification) trên điện thoại. Kênh chính vẫn dùng cho thảo luận thường ngày, nhưng không còn áp lực phải đọc mọi tin nhắn.

- Kết quả:

- Tỷ lệ bỏ sót thông báo quan trọng giảm từ khoảng 30% xuống còn 0% sau 2 ngày áp dụng.
- Thời gian tìm lại thông tin cũ (ví dụ quyết định về liều statin) giảm từ 5-7 phút xuống dưới 1 phút nhờ thread.
- Các thành viên cảm thấy Teams trở nên “gọn gàng” hơn, không bị quá tải thông tin, từ đó tăng hiệu suất thảo luận chuyên môn

V. TỔNG KẾT

- Quá trình thực hiện dự án phân tích case lâm sàng tăng huyết áp từ giai đoạn xây dựng đề cương đến hoàn thiện báo cáo đã cho thấy một thực tế: hiệu quả của các nền tảng công cụ số không chỉ phụ thuộc vào tính năng kỹ thuật mà còn chịu ảnh hưởng quyết định bởi năng lực tổ chức và mức độ tuân thủ quy trình của nhóm. Nói cách khác, công cụ chỉ là phương tiện, còn tư duy quản trị hệ thống mới là yếu tố then chốt.

- Thực tiễn dự án đã chứng minh rằng việc vận hành đồng bộ hệ sinh thái số – bao gồm thiết lập luồng công việc Kanban trên Trello, phân quyền truy cập tài nguyên trên Google Drive, kiểm soát chất lượng nội dung qua Google Docs và điều phối thảo luận trên Microsoft Teams – đã giúp nhóm giải quyết triệt để các rủi ro về phân mảnh thông tin, xung đột chỉnh sửa và chậm tiến độ. Kết quả đạt được bao gồm: tối ưu hóa thời gian xử

lý công việc, loại bỏ tình trạng chồng chéo nhiệm vụ và thiết lập một môi trường làm việc minh bạch, có khả năng kiểm soát cao.

- Hơn cả một bài tập học thuật, dự án này đóng vai trò như một đợt thực hành tổng hợp về năng lực thích ứng công nghệ. Những vướng mắc ban đầu và quá trình nhóm chủ động xây dựng giải pháp khắc phục trên từng nền tảng chính là thước đo thực chất cho kỹ năng làm việc số. Từ trải nghiệm này, có thể khẳng định rằng việc thành thạo quản trị đa công cụ là một năng lực cốt lõi, trang bị cho người học sự tự chủ, tính kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp – những yếu tố nền tảng để thích ứng với bất kỳ môi trường làm việc số nào trong tương lai.